



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : مياده محمود احمد عطيه
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الوراق
رقم البطاقة : 28210031602564 رقم التليفون : 01146714114
العنوان : ممممممممممممممممم
العمر (تاريخ الميلاد) : 03-10-1982 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: مياده محمود احمد عطيه National ID: 28210031602564	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



١٢:١٨ ص





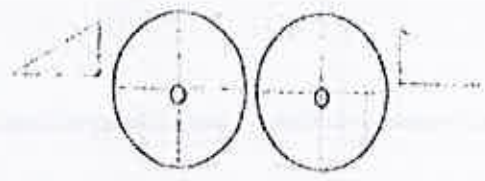
وزارة الصحة
المملكة العربية السعودية

الطبيب العام
100

MDT FORM

١١٤٦٧١٤١١٤

Name	مينا محمد
Age	38
MRN	
ID	٢٨٢١٠٢١٧٤٠٢١٤
Co morbidity	Rheumatoid



Pre-menopausal

Clinical Data

Bx:	IDC GII	SM:	
IMC:		Mets Workup:	
ER:	815		
PR:	818		
Hert:	-ve		
Ki67:			
Left breast cancer PT2N1M			
COMMENT: (2-5x) 3-17-6 ECH			
Done up front w L.E & ALND			

MDT OUTCOME & PLAN

Echerberson	
Re-adjust therapy	EC x4 / cyclo x4
- PORT	(Review for Rheumatoid medication for possible chemotherapy interaction)
- Hormonal tilt	

MEDICAL ONCOLOGY	SURGEON	RADIOLOGY	PATHOLOGY
7/5/15			جاسر المحمدي

Name: مياده محمود احمد عطيه		
MR. : 5749		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته تاريخ وساعة الدخول : تاريخ وساعة الخروج :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient underwent right breast wide local excision with axillary lymph node dissection (T2 N3/17) in 2021, followed by adjuvant chemotherapy consisting of epirubicin and cyclophosphamide plus taxotere for four cycles, and adjuvant hormonal therapy with femara. A bone scan performed in August 2025 was negative, and a subsequent scan in September 2025 remained free of disease. The patient presented for administration of Zoladex 10.8 mg, continued femara, and supportive care for a planned three-month course. The patient was prescribed femara, supportive care, and Zoladex 10.8 mg for three months, with the next follow-up scheduled for 6 August 2026. The patient, currently on hormonal therapy with femara for three months, was scheduled for an annual CT chest-abdomen-pelvis. The patient reported right- and left-hypochondrial pain, which was attributed to the CT scan. The patient's disease status remained free of metastasis as of August 2025, and a pause in treatment was noted in June 2026 with continued Zoladex and femara for three months. The current plan is to continue Zoladex and femara for the prescribed three-month duration.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	18-09-2026 التاريخ :
	نهي سعيد علي محمد	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



National Women's Health Initiative
Pathology Lab

مركز باثولوجي المبادرة القومية لصحة المرأة

Pathology Report

115 TV 112
11/11/21
C-C1

Name: ميادة محمود احمد

Age: 44 years.

Clinical data: Left breast cancer

Specimen type: Left breast BCS, SLN, and axillary clearance

Date (Received): 20/6/2021.

Date (reported): 4/7/2021

Lab. Number: 1283 / 21

Hospital Number:

Gross Examination:

- Procedure: Three specimens received; 1) Left WLE specimen measures 7x4x2 cm, with covering skin ellipse 5x1.5 cm 2) SLN; three nodules stained blue, up to 2 cm 3) Axillary lymph nodes; 14 nodules, the largest was 2 cm.
- Localization:
- Tumor extent
 - Number: an ill defined hard grayish white mass
 - Size: 2.5x1.6x1 cm
 - Skin involvement: No
- Distance from margins: Least margin was 1 cm
- Lymph nodes number and size: 3 SLN, 14 Axillary lymph nodes
- Additional pathologic findings: N/A
- Immunohistochemistry technique: N/A

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation - nuclear pleomorphism - mitosis): G II

Name : Mayada Mahmoud Ahmed Atieh

Date : 29-08-2025 01:08

Branch : Doldi

Medical No. : 189626

Ref.Physician Prof : Gostaf Roseh Hospital

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- 43-year-old lady, with history of left breast cancer, referred for metastatic workup.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- No abnormal active or cold focal bony lesions that may account for metastatic bone disease could be seen all over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

Call Center 19656

Patient Name: Mayada Mahmoud Ahmed Atteya Ezz
Exam : CT CAP(CT Chest Abd. Pelvis)
Medical ID: 1881/2021

Date : 18/08/2025
Age : 42 Year(s)
Pat. ID: 11557

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

A known case of left breast cancer, compared to last study dated 16/9/2024.

I-Chest: -

- Few bilateral tiny millimetric calcified pulmonary nodules are seen, likely post granulomatous infection.
- Newly noted Few enlarged mediastinal lymph nodes the largest at subcarinal group 8 x6 mm.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II-Abdomen & pelvis:

Stationary course:

- The liver is enlarged with homogenous fatty CT texture. No definite focal lesions (on non contrast base) or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with back-pressure changes. Apart from right renal radiodense stone.
- Right renal upper calyceal stone 6mm
- Normal appearance of the pancreas, and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- IUCD is noted in place.
- Newly noted Right iliac fossa peritoneal nodules measures about 5mm.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton:**

Stationary course:

- No definite worrisome lytic or sclerotic focal lesions.
- Grade I spondylolisthesis (mild slippage of L4 over L5).
- Tiny sclerotic lesion at right humeral head likely bony island.

Opinion:

A case of left CBS

Newly noted:

- Few mediastinal sub centemetric L. Ns likely reactive for follow up.
- Right iliac fossa peritoneal nodules .
- Rather stationary course of rest of the study.

Dr. Reham Khedr...MD

Signature Reham Khader
21/08/2025 9:20 PM